

«Негоспітальна пневмонія»

Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Виконати порівняльну перкусію легень.
- Оцінити клінічний аналіз крові.
- Оцінити аналіз на мокротиння.
- Оцінити рентгенографію органів грудної клітини.
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

9. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом негоспітальна пневмонія».

Ви лікар-терапевт терапевтичного відділення. До Вас звернувся чоловік, 40 років, слюсар.

Скарги: на кашель зі слизово-гнійним мокротинням, підвищення температури тіла до 39°C, помірну задишку при фізичних навантаженнях, біль в грудній клітці при кашлі, загальну слабкість.

Анамнез захворювання: вважає себе хворим протягом п'яти днів, коли після переохолодження з'явилися вищевказані скарги. Приймав парацетамол, ібупрофен із незначним поліпшенням стану.

Анамнез життя: туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет, виразкову хворобу шлунку та 12-ти палої кишки заперечує. Протягом життя хворів на ГРВІ. Операції, травми протягом життя – заперечує. Алергійні реакції та непереносимість ліків – заперечує. Спадковість не обтяжено.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості. Шкірні покриви чисті, блідо-рожеві. Температура тіла 38,2°C. Периферичних набряків немає. При аускультії у нижніх відділах ліворуч - дихання послаблене, вислуховуються дрібнопухирцеві хрипи. ЧДР – 25 за хвилину. SpO₂ 97 %. Тони серця ритмічні, ясні, ЧСС=Пульс=92 за хв., АТ на обох руках 120/70 мм рт.ст. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

- Додаток 1 Клінічний аналіз крові

Показник	Результат	Норма
Еритроцити, *10 ¹² /л	4,6	ч. 4,5-5,0 ж. 3,7-4,7
Гемоглобін, г/л	140	ч. 132-164 ж. 115-145
КП	0,9	0,85-1,05
Ретікулоцити, ‰		2-12
ШЗЕ, мм/год	25	ч. 2-10 ж. 2-15
Тромбоцити, *10 ⁹ /л	200	180-320
Гематокрит, %		ч. 40-48 ж. 36-41

Лейкоцити, *10 ⁹ /л	13,5	4-9
Лейкоцитарна формула		
Нейтрофіліпаличкоядерні, %	11	1-5
Нейтрофилисегментоядерні, %	64	47-72
Еозинофили, %	5	1-5
Базофіли, %	1	0-1
Лімфоцити, %	23	20-40
Моноцити, %	1	2-10

- Додаток 2 Аналіз на харкотиння

Показник	Результат	Норма
Кількість за добу, мл	50	10-100
Запах	немає	Відсутній
Шаруватість	Відсутня	Відсутня
Реакція (рН)	Лужна	Нейтральна або лужна
Характер	Слизово-гнійниа	Слизовий
Мікроскопія		
Нейтрофіли	-	
Еозинофіли	-	
Еритроцити	-	
Лейкоцити	багато	
Плоский епітелій	немає	
Альвеолярніклітини	1-2 в полі зору	
Спіралі Куршмана	відсутні	
Кристали Шарко-Лейдена	відсутні	
Атипові клітини	немає	
МБТ	немає	

- Додаток 3.Рентгенографія органів грудної клітини



Робоче місце здобувача освіти

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря-терапевта обов'язково повинно включати:

№ з/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
Перелік медичного обладнання(багаторазового використання)		
1	Контейнер для зборі відходів класу А (класу В)	1 шт.

№ з/п	Перелік медичного обладнання(одноразове використання)	Кількість на 1 спробу
1	Ватні кульки для обробки шкіри рук	2 шт
Перелік медичного обладнання (симуляційне обладнання)		
1	Манекен-симулятор аускультатії (програмування не передбачено)	1 шт.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
	інформовану згоду отримано; руки оброблено на гігієнічному рівні.	
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ПОРІВНЯЛЬНА ПЕРКУСІЯ ЛЕГЕНЬ»		
	Порівняльна перкусія легень: симетричність (визначають характер звуку в кожній точці	

	перкусії й порівнюють його з перкуторним звуком на протилежній стороні, а також зі звуком на сусідніх ділянках легенів).	
	Порівняльна перкусія надключичних ділянок (палець-плесиметр ставиться паралельно ключиці)	
	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність спереду: передня поверхня грудної клітки (праворуч перкусія проводиться до зміни перкуторного звуку над усією половиною грудної клітки, а ліворуч – з урахуванням відносної серцевої тупості). Перкусія проводиться по середньоключичним лініям і вирівнюється до рівня 3 міжребер'я (далі проводиться тільки праворуч).	
	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність в пахвинних областях (при цьому хворій ставить руки на пояс).	
	Порівняльна перкусія легень: коректна послідовність позаду: у надлопаткових областях палець перебуває в горизонтальному положенні, у міжлопатковому просторі – у вертикальному положенні, під лопатками – знову горизонтально.	Коли здобувач освіти буде перкутувати від 6 міжребер'ї ліворуч донизу – треба сказати «Притуплення».
	Оцінка перкуторного звуку над всією поверхнею легень: <i>при порівняльній перкусії легень визначається притуплення звуку від 6 міжребер'я донизу ліворуч</i>	
	Самопочуття пацієнта задовільне	
3. ДІАГНОСТИКА:		
Оцінити клінічний аналіз крові (Додаток 1)	Лейкоцитоз ($13,5 \cdot 10^9 / \text{л}$) із зсувом формули ліворуч (нейтрофіли паличкоядерні 11%), пришвидшення ШЗЕ, що свідчить про запальний процес	
Оцінити аналіз на харкотиння (Додаток 2)	Слизово-гнійний характер мокротиння, наявність великої кількості лейкоцитів свідчить про наявність запального процесу..	
Оцінити рентгенографію органів грудної клітини (Додаток 3)	В нижній долі лівої легені визначається ділянка затемнення, що свідчить про наявність запальної інфільтрації (пневмонії) в нижній долі лівої легені	

<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Негоспітальна пневмонія II група, нетяжка, в нижніх відділах лівої легені	
4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ		
<i>Призначено наступні ліки:</i>	• Антибіотикотерапія: пероральний прийом захищений амінопеніцилін (амоксцилін/клавуланова кислота) або цефалоспорин II покоління (цефуроксимуаксетил) • Альтернативною терапією може бути застосування фторхінолону III–IV покоління • Відхаркуючі препарати (муколітики) • Жарознижуючі препарати за потребою.	
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:		
	Дотримування здорового харчування та відпочинку. Виконання дихальних вправ.	